FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : Une cohorte ne teste pas une prescription

Wu et ses collègues (2023) analysent les activités de 10 318 personnes en Australie, âgées d'au moins 70 ans et généralement en bonne santé à l'inclusion. Leur étude examine l'incidence de démence avec des modèles ajustés sur plusieurs caractéristiques.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

Échecs et Alzheimer : ce que les études permettent de dire

Wu et ses collègues (2023) analysent les activités de 10 318 personnes en Australie, âgées d'au moins 70 ans et généralement en bonne santé à l'inclusion. Leur étude examine l'incidence de démence avec des modèles ajustés sur plusieurs caractéristiques.

Catégorie étudiée	HR ajusté	Intervalle de confiance à 95 %
Activités de littératie adulte	0,89	0,85-0,93
Activités mentales actives	0,91	0,87-0,95

Les activités mentales actives regroupent notamment jeux, cartes, échecs, mots croisés et puzzles. L'étude ne permet pas d'en extraire un effet propre aux échecs.

Ces HR sont des rapports de risques instantanés dans le modèle. Ils ne sont pas une réduction absolue de 11 ou 9 points de pourcentage ni une probabilité individuelle d'éviter Alzheimer. La mesure porte sur la démence, pas exclusivement sur cette maladie.

L'ajustement statistique réduit certaines différences entre participants sans supprimer toutes les explications possibles. Des personnes qui restent en meilleure santé peuvent aussi continuer davantage leurs activités. L'étude ne répartit pas les participants au hasard entre « jouer aux échecs » et « ne pas jouer ».

Prévention et accompagnement sont deux questions

Un essai mené auprès de personnes déjà diagnostiquées peut mesurer une évolution de l'humeur, du fonctionnement ou d'un score cognitif. Même positif, ce résultat ne démontrerait pas une prévention chez des personnes bien portantes.

Il faut donc examiner la population, le type de jeu, le groupe de comparaison et le critère mesuré. Les résultats d'un autre jeu ou d'un dispositif thérapeutique encadré ne se transfèrent pas automatiquement à une partie d'échecs en club.

Garder les bons critères

Pour une activité de loisir, tu peux choisir un objectif observable : prendre plaisir à une séance, rencontrer d'autres joueurs ou apprendre une finale. Un changement d'humeur ou de qualité de vie compte pour la personne, mais ne mesure pas une modification de la maladie.

Aucun nombre de séances par semaine ni durée de 45 ou 60 minutes ne constitue ici une dose préventive validée. Si une étude pilote utilise cette durée, elle décrit son protocole ; elle ne prescrit pas la même chose à tout le monde.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/echecs-alzheimer-prevention-declin-cognitif/